Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

ABDOME AGUDO HEMORRÁGICO

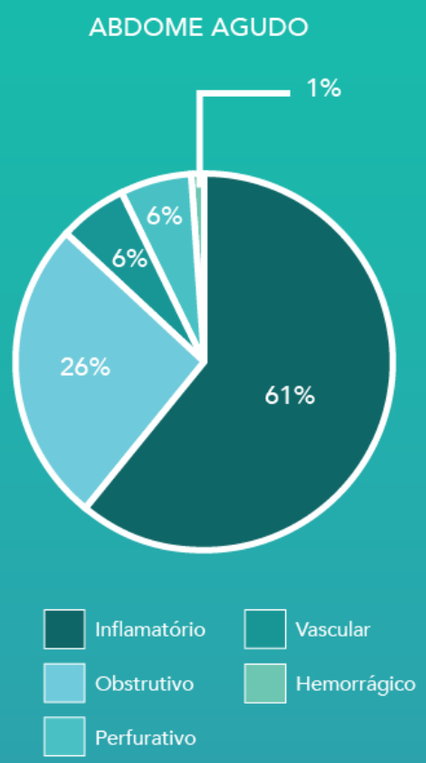
CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO:

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno! Finalmente chegamos ao nosso último livro sobre Abdome Agudo! Agora, vamos falar um pouco sobre o Abdome Agudo Hemorrágico, o que menos cai em prova, veja no gráfico abaixo. E, por ser pouco cobrado, vou ser bem objetiva e colocar aqui apenas as patologias que costumam aparecer nas provas.



@prof.renathapaiva

@estrategiamed

Estratégia MED

/estrategiamed

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

Estratégia MED

SUMÁRIO

1.0 INTRODUÇÃO 4
1.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO 4
1.2 TRATAMENTO 5
2.0 GRAVIDEZ ECTÓPICA ROTA 7
2.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO 8
2.2 DIAGNÓSTICO 8
2.3 TRATAMENTO 9
3.0 CISTO OVARIANO ROTO 10
3.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO 10
3.2 DIAGNÓSTICO 11
3.3 TRATAMENTO 11
4.0 ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL ROTO 14
4.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO 15
4.2 DIAGNÓSTICO 16
4.3 TRATAMENTO 17
5.0 RUPTURA ESPLÊNICA ESPONTÂNEA 27
6.0 LISTA DE QUESTÕES 28
7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 29
8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 30

CAPÍTULO
1.0 INTRODUÇÃO

O abdome agudo hemorrágico caracteriza-se pela presença de sangue livre na cavidade abdominal (hemoperitônio) de origem não traumática. Não confunda com hemorragia digestiva, em que o sangue está dentro do trato gastrointestinal, não livre na cavidade peritoneal.

São exemplos de abdome agudo hemorrágico:

- **Gravidez ectópica rota (causa mais comum);**
- Cisto ovariano roto;
- Ruptura de aneurisma de aorta abdominal (AAA);
- Ruptura de aneurisma de artéria esplênica (aneurisma visceral mais comum);
- Ruptura esplênica e hepática espontânea;
- Adenoma hepático roto (tumor hepático que mais rompe – mulher jovem em uso de ACO);
- Discrasias sanguíneas.



Em mulheres, o abdome agudo hemorrágico está associado em maior número a causas ginecológicas e obstétricas; nos pacientes jovens, à ruptura de aneurismas das artérias viscerais; e nos idosos, à ruptura de tumores e aneurismas de aorta abdominal.

1.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO

No abdome agudo hemorrágico, geralmente o paciente apresenta-se com dor abdominal intensa associada a alterações hemodinâmicas secundárias à perda sanguínea, como palidez cutaneomucosa, sudorese fria, pulsos filiformes, taquicardia, taquipneia, hipotensão arterial e rebaixamento do nível de consciência. Dessa forma, sempre devemos suspeitar de um abdome agudo hemorrágico no paciente com dor abdominal aguda e **CHOQUE HIPOVOLÊMICO**. Nem sempre o paciente apresenta sinais de peritonite, pois o sangue é pouco irritativo ao peritônio parietal. Veja as secreções que mais irritam o peritônio, em ordem decrescente:



A maioria dos autores descrevem o **Sinal de Lafond**, dor referida no ombro, para patologias ginecológicas, e o **sinal de Kehr** (dor no ombro esquerdo) para ruptura esplênica, ambos causados por irritação do nervo frênico no diafragma pelo sangue livre na cavidade peritoneal.

1.2 TRATAMENTO

O tratamento do abdome agudo hemorrágico, assim como no trauma abdominal com lesão de víscera maciça, envolve tratar o choque, ou seja, hidratação endovenosa com cristaloide por meio de acesso venoso periférico, transfusão sanguínea (se necessário) e controle da hemorragia imediato, quase sempre cirúrgico, por meio de laparotomia exploradora. Lembre-se de que a l**aparoscopia está contraindicada no paciente instável hemodinamicamente**.

DOR ABDOMINAL AGUDA + CHOQUE HIPOVOLÊMICO = ABDOME AGUDO HEMORRÁGICO.

No quadro acima, coloquei as principais etiologias do abdome agudo hemorrágico, mas não vou me aprofundar em todas, pois não costumam cair em provas, basta você saber que são causas de hemorragia intra-abdominal. Vou falar apenas sobre as mais frequentes e "queridinhas" das bancas.

CAI NA PROVA

(HOSPITAL SANTO AMARO - GUARUJÁ - HSA – GUARUJÁ 2019) Das alternativas abaixo, qual não é causa de abdome agudo hemorrágico:

A) Ruptura espontânea esplênica
B) Gravidez tubária rota
C) Adenoma hepático roto
D) Aneurisma da artéria esplênica
E) Úlcera gástrica hemorrágica

COMENTÁRIO:

Meu querido aluno, para você acertar essa questão, você deve imaginar o que leva a um hemoperitônio, ou seja, sangue dentro da cavidade peritoneal!

Correta a alternativa A. A ruptura esplênica é uma condição rara, que se refere à ruptura do baço sem história de trauma. Pode ser idiopática (baço normal) ou, mais frequentemente, quando o baço é acometido por neoplasias, doenças infecciosas ou hematológicas.

Correta a alternativa B. A prenhez ectópica rota é a causa mais comum de abdome agudo hemorrágico. Acomete pacientes jovens, em idade fértil, e manifesta-se com dor abdominal súbita e intensa no abdome inferior associada a sinais de choque, como taquicardia e hipotensão, e sangramento vaginal anormal. O diagnóstico é confirmado pela ultrassonografia transvaginal e pélvica e dosagem do BHCG, que sempre será positivo!

Correta a alternativa C. O adenoma hepático é um tumor benigno, associado a níveis elevados de estrógeno. Acomete principalmente mulheres em idade fértil, em uso de contraceptivos orais. Se houver ruptura, causa hemoperitônio. Logo, é uma causa de abdome agudo hemorrágico.

Correta a alternativa D. O aneurisma da artéria esplênica é raro e corresponde ao aneurisma visceral mais comum. Acomete principalmente mulheres multíparas e portadores de hipertensão portal.

Incorreta a alternativa E: A úlcera gástrica hemorrágica manifesta-se por hematêmese e/ou melena. O sangramento está "dentro" do trato gastrointestinal, e não na cavidade abdominal, por isso não é um abdome agudo hemorrágico.

CAI NA PROVA

(CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR - UNICESUMAR 2019) O abdome agudo, que pode ser decorrente de inúmeras doenças, configura um quadro clínico de dor dos mais importantes e frequentes na prática clínica. Pela sua gravidade, necessita de condutas diagnósticas e terapêuticas urgentes. Assinale a alternativa que apresenta uma causa de abdome agudo hemorrágico.

A) Trombose mesentérica.
B) Prenhez ectópica rota.
C) Crise de falcização.
D) Diverticulite.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A. A trombose mesentérica é causa de abdome agudo vascular.

Correta a alternativa B: A prenhez ectópica rota cursa com dor abdominal aguda e sinais de choque hipovolêmico devido ao hemoperitônio. Logo, é causa de abdome agudo hemorrágico e exige tratamento cirúrgico de emergência.

Incorreta a alternativa C. A crise de falcização é causa hematológica de dor abdominal aguda não cirúrgica.

Incorreta a alternativa D. Diverticulite aguda é causa de abdome agudo inflamatório.

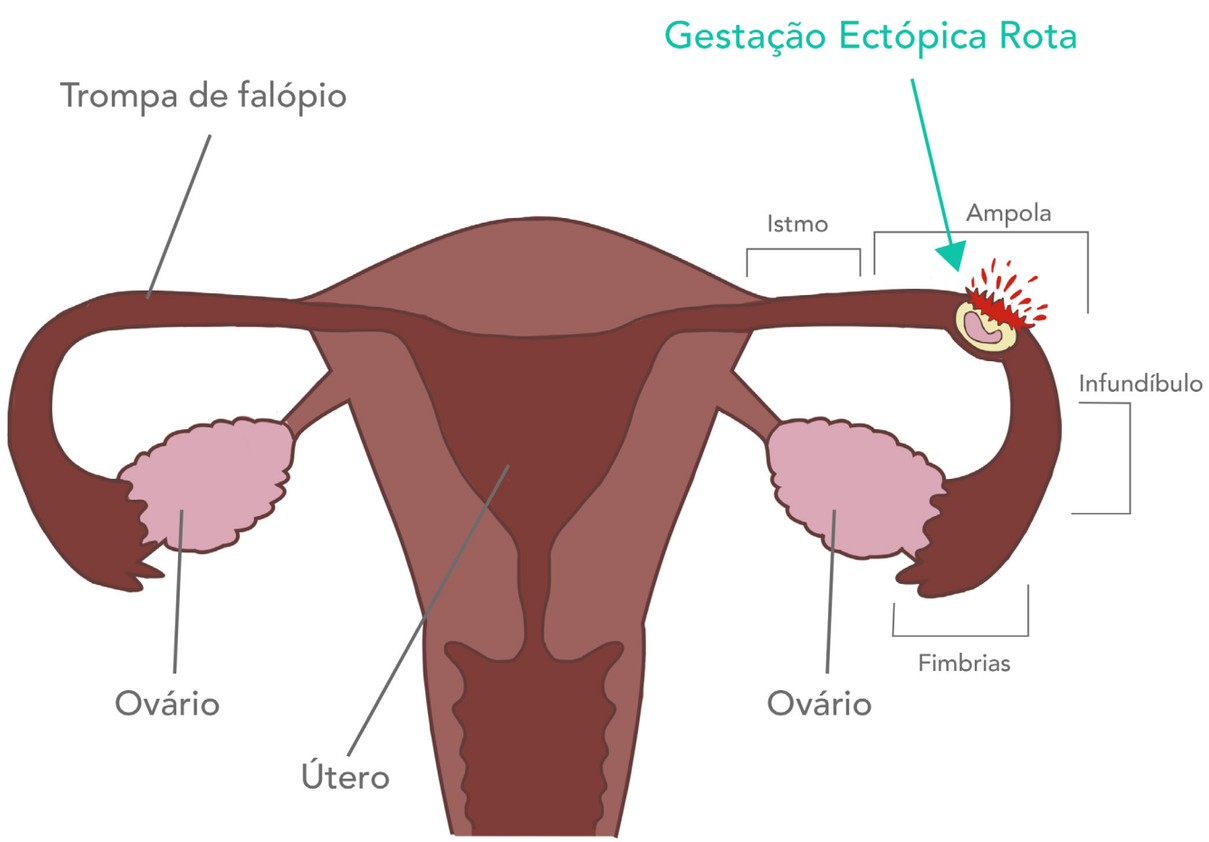
CAPÍTULO

2.0 GRAVIDEZ ECTÓPICA ROTA

A prenhez ou gravidez ectópica rota é a **causa mais comum do abdome agudo hemorrágico**. É a principal causa de mortalidade materna relacionada à gravidez no primeiro trimestre, sendo que a maioria dessas mortes ocorre antes da chegada da paciente ao pronto-socorro.

A maioria dos casos de gravidez ectópica ocorre na tuba uterina (96 %) e é mais frequente do lado direito. A localização mais comum da gestação ectópica é na região ampular da tuba uterina, no entanto a rotura é mais frequente na região ístmica.

GRAVIDEZ ECTÓPICA ROTA





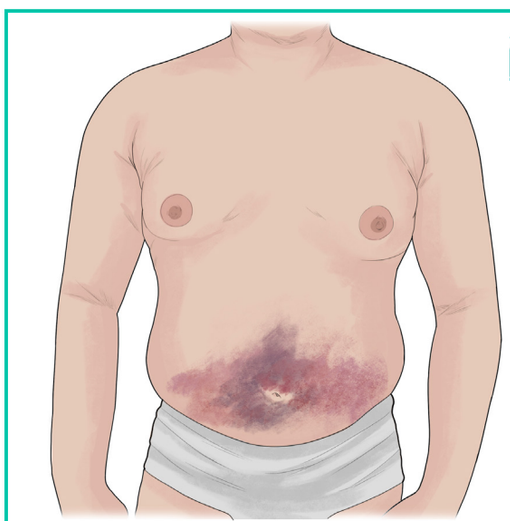
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA GESTAÇÃO ECTÓPICA:

- História de doença inflamatória pélvica;
- Gravidez tubária anterior;
- Cirurgia tubária anterior;
- História de endometriose;
- Dispositivo intrauterino permanente (DIU); e
- Tabagismo.

2.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO

Devemos suspeitar de um abdome agudo hemorrágico por gravidez ectópica rota na paciente em idade reprodutiva, com histórico de **amenorreia, sangramento vaginal anormal**, que cursa com **dor abdominal súbita**, de forte intensidade, contínua, inicialmente no abdome inferior, e **sinais de choque** (taquicardia, hipotensão, sudorese, lipotimia). Se houver sangramento intra-abdominal suficiente para atingir o diafragma, pode apresentar dor no ombro, devido à irritação diafragmática (sinal de Lafond).

No exame físico, o abdome pode estar distendido e o paciente pode apresentar sensibilidade difusa ou localizada. Um sinal clínico que também pode estar presente é o sinal de Cullen, que consiste na presença de equimose periumbilical, indicativo de hemorragia intra-abdominal. No exame especular, pode haver abaulamento do fundo de saco de Douglas, indicando a presença de hemoperitônio. E, no toque vaginal, ao comprimir-se o fundo de saco, a paciente apresenta dor de forte intensidade, sinal conhecido como **"sinal de Proust" ou "grito de Douglas"**.



SINAL DE CULLEN
(equimose periumbilical)

2.2 DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é baseado no quadro clínico de dor abdominal aguda, história de atraso menstrual, sangramento vaginal e sinais de choque, em uma paciente em idade fértil, com **BHCG positivo** e ultrassonografia abdominal e/ou transvaginal evidenciando:

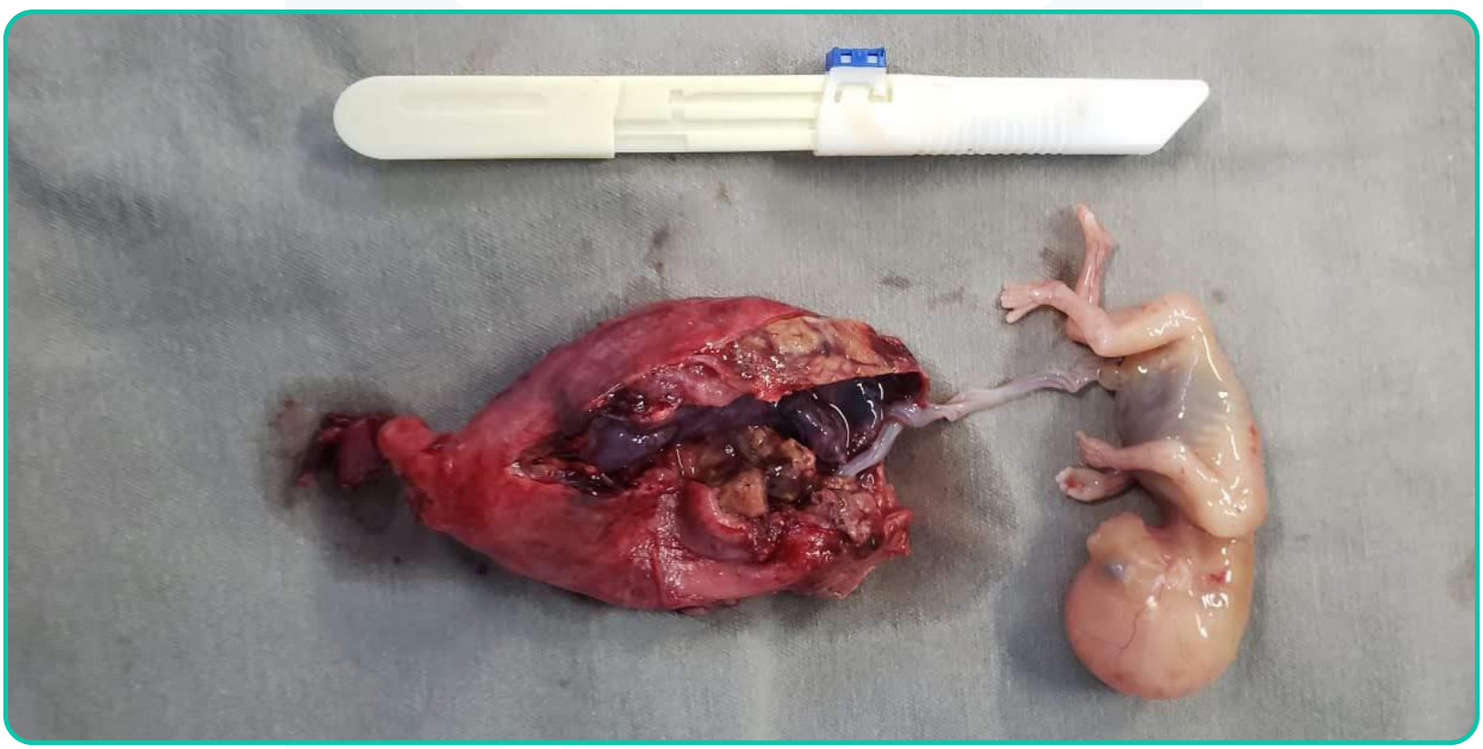
- Líquido livre na cavidade (hemoperitônio);
- Ausência de gestação intrauterina; e
- Massa extrauterina complexa (saco gestacional), geralmente na tuba uterina.

GESTAÇÃO ECTÓPICA = BHCG SEMPRE POSITIVO.

Na punção do fundo de saco de Douglas por via vaginal, chamada **culdocentese**, haverá sangue na aspiração. No entanto, esse procedimento não é mais realizado rotineiramente.

2.3 TRATAMENTO

O tratamento da gravidez ectópica é cirúrgico de emergência, e a cirurgia a ser realizada é a salpingectomia. Geralmente, o acesso à cavidade abdominal é por laparotomia convencional, uma vez que instabilidade hemodinâmica é contraindicação à laparoscopia.



Salpingectomia – gravidez ectópica rota. Fonte: acervo pessoal Dr. Carlos Eduardo Martins.



GRAVIDEZ ECTÓPICA ROTA

- **Clínica:** dor abdominal súbita e intensa, amenorreia, sangramento vaginal anormal e sinais de choque.
- **Diagnóstico:** BHCG positivo, USG com massa extrauterina (geralmente na trompa), ausência de gestação intrauterina e líquido livre (hemoperitônio).
- **Tratamento:** laparotomia e salpingectomia.

CAPÍTULO

3.0 CISTO OVARIANO ROTO

A ruptura do cisto ovariano, comum em mulheres na idade reprodutiva, resulta na liberação de fluido do cisto ou sangue que podem irritar a cavidade peritoneal. A ruptura fisiológica de pequenos cistos foliculares que ocorre a cada ciclo ovulatório geralmente não é significativa clinicamente. Na maioria das mulheres, é assintomático ou há dor leve no meio do ciclo (também conhecida como mittelschmerz ou “dor do meio”).

3.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO

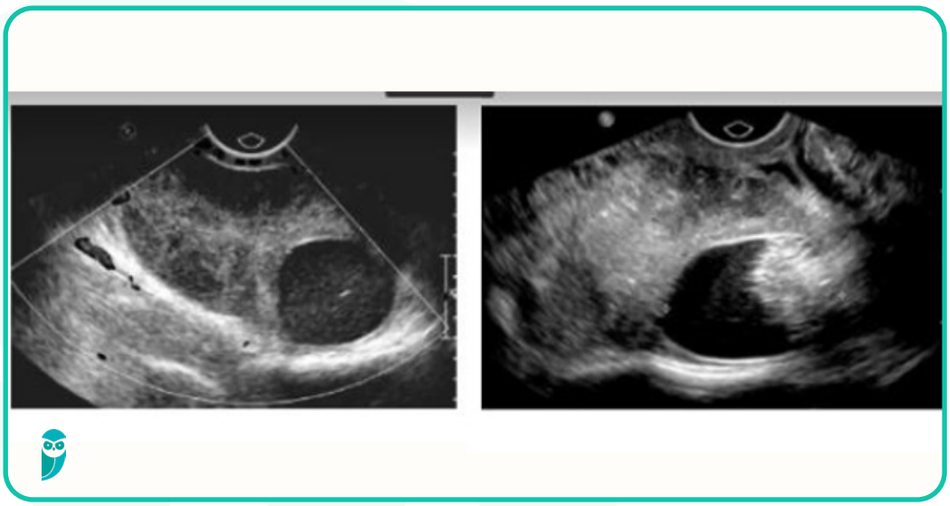
A apresentação clássica da ruptura de cisto ovariano é o **início súbito de dor intensa, unilateral** e localizada no quadrante inferior do abdome (direito ou esquerdo), **geralmente durante atividades físicas extenuantes, como exercícios ou relações sexuais**. Quando há hemorragia maciça, com hemoperitônio volumoso, além dos sinais de choque, a paciente pode referir dor no ombro por irritação diafragmática (sinal de Lafond). No exame físico do abdome, pode apresentar dor abdominal localizada ou difusa, inclusive com descompressão brusca positiva, a depender do volume de sangue livre na cavidade. A hemorragia intra-abdominal pode estar associada ao sinal de Cullen (equimoses periumbilicais).

3.2 DIAGNÓSTICO

As causas ginecológicas mais comuns de hemoperitônio são a ruptura de cisto ovariano e a gravidez ectópica. Por isso, é **importante excluir a gravidez ectópica rota** por meio da dosagem do BHCG, pois é necessário tratamento cirúrgico de emergência.

A anemia pode estar presente em exames laboratoriais. No entanto, em uma paciente jovem e saudável, uma grande perda de sangue que ocorre rapidamente pode não mostrar inicialmente queda do hematócrito.

Excluindo uma prenhez ectópica rota, o diagnóstico de cisto ovariano roto pode ser feito pela ultrassonografia, em que será visualizada **massa anexial e líquido livre na pelve**.



Cisto de ovário. Fonte: prova de acesso direto IASMPE 2017.

3.3 TRATAMENTO

Pacientes com ruptura de cisto ovariano geralmente sangram uma quantidade pequena ou moderada e o sangramento é autolimitado. O tratamento pode ser conduzido de forma conservadora, com internação, repouso, hidratação endovenosa, analgesia, controle hematimétrico, exame físico e ultrassonografia seriados. No entanto, se a paciente já se apresentar com **instabilidade hemodinâmica ou houver falha durante a observação clínica**, o tratamento deverá ser cirúrgico, com **laparotomia ou laparoscopia** (se estável) e controle da hemorragia por meio de uma **cistectomia ou ooforectomia**.

CISTO OVARIANO ROTO

Clínica: dor abdominal súbita, intensa, unilateral, geralmente após relação sexual.

Diagnóstico: BHCG negativo, USG com massa anexial e líquido livre.

Tratamento:

Estável: observação.

Instável: tratamento cirúrgico.



CAI NA PROVA

(SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA - SCMMA 2017) Mulher de 29 anos, usuária de DIU há 1 ano, chega ao pronto-socorro com dor em fossa ilíaca direita de início súbito, acompanhada de tontura, náuseas e escurecimento visual e sangramento vaginal. Referia última menstruação há cerca de 40 dias. Ao exame, está descorada, PA 80x40 mmHg pulso de 110 bat/min. Abdome tenso, doloroso em fossa ilíaca direita, com descompressão brusca presente. Observa-se sangramento pelo colo uterino, colo impérvio, útero discretamente aumentado e doloroso, abaulamento do fórnice vaginal posterior. Qual é o diagnóstico mais provável?

A) Abortamento evitável.
B) Cisto roto de ovário.
C) Prenhez ectópica rota.
D) Abscesso tubo-ovariano.
E) Abortamento incompleto.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A. O abortamento evitável caracteriza-se por gestação tópica com sangramento vaginal e colo uterino impérvio. Não apresenta dor abdominal com peritonite, sinais de choque e abaulamento do fórnice vaginal posterior (hemoperitônio).

Incorreta a alternativa B. O cisto ovariano roto é um dos principais diagnósticos diferenciais da gestação ectópica rota, pois acomete pacientes jovens, em idade reprodutiva, e o quadro clínico é semelhante, com dor abdominal súbita, podendo evoluir para choque hipovolêmico, a depender do volume de sangramento apresentado. Mas, sangramento vaginal e histórico de atraso menstrual não estão presentes no cisto ovariano roto.

Correta a alternativa C: Estamos diante de uma paciente jovem, em idade fértil, com quadro clínico clássico de gestação ectópica rota, pois apresenta dor abdominal súbita, atraso menstrual, sangramento vaginal e sinais de choque (taquicardia e hipotensão). O abaulamento do fórnice vaginal posterior indica líquido livre na pelve (hemoperitônio). Além disso, a paciente é usuária de DIU, fator de risco para gestação ectópica.

Incorreta a alternativa D. O abscesso tubo-ovariano é geralmente uma complicação da doença inflamatória pélvica. A apresentação clássica inclui dor abdominal baixa aguda, febre (nem sempre presente), calafrios e corrimento vaginal. O histórico de atraso menstrual, sangramento vaginal e evolução rápida para choque falam contra esse diagnóstico.

Incorreta a alternativa E. O aborto incompleto caracteriza-se por perda gestacional incompleta em que o eco endometrial se mantém espessado. Não apresenta dor abdominal difusa com sinais de choque hipovolêmico.

CAI NA PROVA

(FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS - FMP - UNIFASE 2020) Paciente de 35 anos de idade, sexo feminino, procurou auxílio médico na Emergência com queixa de dor abdominal súbita na fossa ilíaca direita acompanhada de sudorese, taquicardia e hipotensão. Na anamnese relatava ter sido submetida a laqueadura tubária. Qual o diagnóstico mais provável para esta paciente?

A) Apendicite aguda.
B) Doença Inflamatória Pélvica.
C) Cisto hemático roto de ovário.
D) Torção de ovário.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de uma paciente jovem, em idade fértil, com dor abdominal súbita em fossa ilíaca direita associada a sinais de choque (sudorese, taquicardia e hipotensão). Dor abdominal súbita, associada a sinais de choque, em uma paciente jovem, devemos pensar em duas hipóteses diagnósticas: cisto ovariano roto e gravidez ectópica rota. Essa última é pouco provável em uma paciente com histórico de ligadura tubária prévia.

Incorreta a alternativa A. O quadro típico da apendicite aguda é uma dor periumbilical com irradiação para a fossa ilíaca direita, geralmente associada à anorexia, náuseas, vômitos e febre baixa. A dor súbita e a repercussão sistêmica rápida falam contra o diagnóstico de apendicite aguda.

Incorreta a alternativa B. A dor abdominal inferior é o principal sintoma da doença inflamatória pélvica (DIP). É comum o relato de dispareunia (dor durante o coito) e febre. No exame pélvico, o achado de secreção endocervical purulenta de odor fétido e sensibilidade anexial ao exame bimanual é fortemente sugestivo de DIP. O quadro súbito com instabilidade não sugere uma DIP.

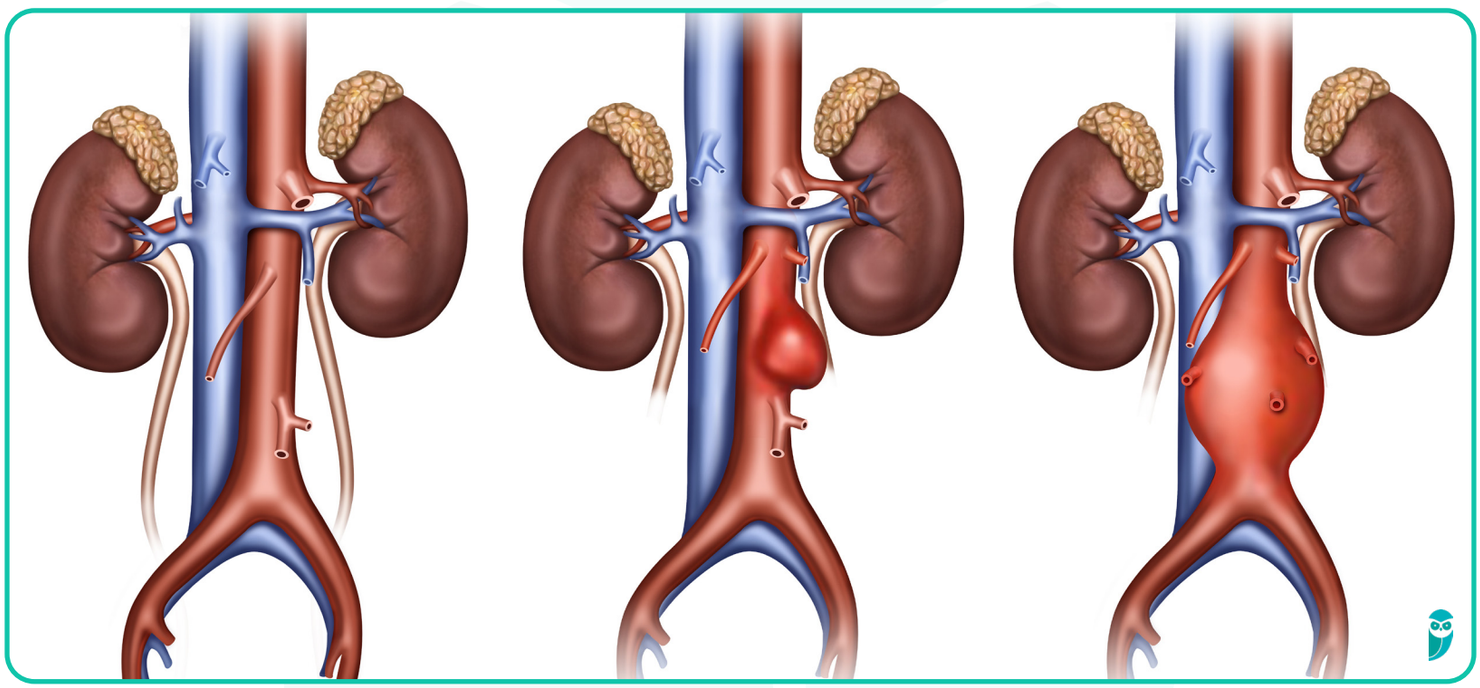
Correta a alternativa C: A presença de instabilidade hemodinâmica e a dor abdominal súbita sugerem uma hemorragia intra-abdominal. Em uma paciente jovem, em idade fértil, as principais hipóteses diagnósticas são prenhez ectópica rota (mas nossa paciente tem ligadura tubária) e cisto ovariano roto.

Incorreta a alternativa D. A maioria dos casos de torção ovariana ocorre em mulheres em idade reprodutiva. Caracteriza-se por uma dor súbita, unilateral, associada à massa anexial, podendo apresentar náuseas e vômitos. A instabilidade também fala contra o diagnóstico de torção ovariana.

CAPÍTULO

4.0 ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL ROTO

Meu querido aluno, neste tópico abordaremos apenas as particularidades do aneurisma de aorta abdominal roto. Em nosso livro de "Cirurgia Vascular", a fisiopatologia, fatores de risco, meios diagnósticos e tratamento do aneurisma de aorta não roto estão bem detalhados.



Aorta normal. Fonte: Shutterstock.

Aneurisma de aorta abdominal infrarrenal (sacular e fusiforme).Fonte: Shutterstock.



Uma aorta abdominal é considerada aneurismática quando maior que 3 cm de diâmetro. O aneurisma da aorta abdominal (AAA) é mais frequente no segmento infrarrenal e o principal fator de risco para ruptura de um aneurisma de aorta é o diâmetro. Um aneurisma ≥ 5,5 cm de diâmetro já tem indicação cirúrgica. Nessa situação, os benefícios de uma cirurgia de correção do aneurisma sobrepujam os riscos.

Os outros fatores de risco relacionados à rotura do aneurisma estão listados na tabela abaixo.

FATORES DE RISCO DE ROTURA DO AAA
Diâmetro do aneurisma superior a 5,5 cm (diretamente proporcional ao risco de rotura)
Aneurisma sacular
Crescimento > 0,5 cm em 6 meses ou > 1cm em um ano
Aneurismas sintomáticos
Tabagismo
Sexo feminino
DPOC
Transplantado cardíaco ou renal

Lembre-se de que algumas doenças do tecido conjuntivo podem desenvolver fraqueza na parede da aorta, sendo consideradas fatores de risco para o desenvolvimento do aneurisma. Como exemplos, podemos citar as **síndromes de Marfan e de Ehlers-Danlos**.

4.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO

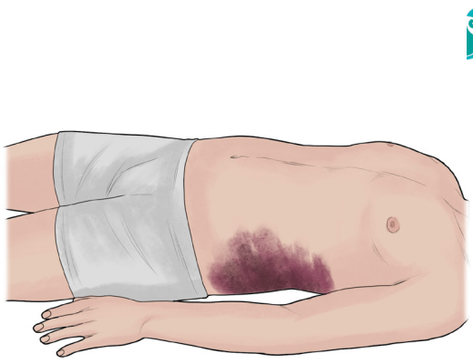
A **tríade clássica do aneurisma abdominal** roto está presente em 50% dos casos e é composta por:



Dor abdominal e/ou lombar intensa.
Hipotensão.
Massa abdominal pulsátil.

Um sinal clínico que pode estar presente é o **sinal de Grey Turner, equimose em flancos**, indicativo de hemorragia retroperitoneal (também presente nos casos de pancreatite necro-hemorrágica).

Nos casos em que a rotura do aneurisma é restrita ao retroperitônio, os sintomas podem não ser evidentes e, em até 30% dos casos, são interpretados erroneamente como cólica renal, diverticulite, isquemia intestinal, entre outros diagnósticos. Portanto, sempre tenha um nível de suspeita diagnóstica elevado. Os aneurismas rotos são urgências/emergências cirúrgicas e negligenciar seu diagnóstico e tratamento em tempo hábil certamente custará a vida do paciente.



SINAL DE GREY-TURNER
(equimose em flancos)

4.2 DIAGNÓSTICO

ANGIOTOMOGRAFIA: para pacientes com suspeita de rotura de AAA, mas **estáveis hemodinamicamente**. Esse método, além de confirmar o diagnóstico, é útil para o planejamento cirúrgico. Na imagem ao lado, nota-se um grande aneurisma da aorta abdominal com sinais de rotura, caracterizados pelo extenso hematoma perirrenal, densificação da gordura adjacente, irregularidades do saco aneurismático.



Fonte: acervo pessoal Dr. Joshua Viana.

ULTRASSONOGRAFIA: pode ser realizada para pacientes com suspeita de rotura de AAA, **instáveis hemodinamicamente**, sem diagnóstico prévio de AAA, mas não é obrigatória. Tem a vantagem de poder ser realizada à beira do leito ou na sala de cirurgia enquanto o paciente está sendo reanimado, sem causar um atraso indevido no atendimento. Pode ser visualizado um hematoma retroperitoneal, mas o local da ruptura geralmente não é identificado.



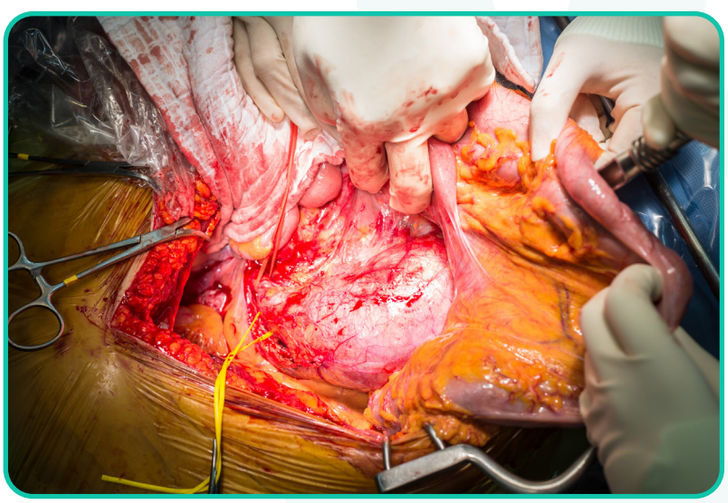
Pacientes **sabidamente portadores de AAA**, que se apresentam com **quadro clínico típico** (dor abdominal/dorsal, massa pulsátil e hipotensão) e instabilidade hemodinâmica não necessitam de **nenhum exame complementar** e devem ser levados **imediatamente ao centro cirúrgico** para controle imediato da hemorragia e reparo do aneurisma. A reposição volêmica é essencial nessas ocasiões. Apesar disso, a **hipotensão permissiva**, ou seja, evitar reposição volêmica agressiva e permitir uma pressão arterial sistólica tão baixas quanto 50 a 70 mmHg, é uma estratégia útil para prevenir mais lacerações da aorta e limitar a perda sanguínea e deve ser considerada para os pacientes conscientes, ou seja, sem sinais de hipoperfusão cerebral.

4.3 TRATAMENTO

Quando o AAA roto é identificado, **o reparo deve ser realizado imediatamente** para que o paciente tenha chance de sobrevivência. Mas, não podemos esquecer que é primordial reanimar o paciente, hidratação endovenosa, coleta de tipagem sanguínea e reserva de sangue e já iniciar transfusão sanguínea, quase sempre necessária.

Os aneurismas com ruptura podem ser reparados por dois métodos: cirurgia aberta convencional e reparo do aneurisma endovascular. A escolha entre cada técnica deve ser individualizada e levar em conta critérios, como a idade, fatores de risco do paciente, configuração anatômica do aneurisma, disponibilidade de radiologia intervencionista para o tratamento endovascular e experiência da equipe cirúrgica.

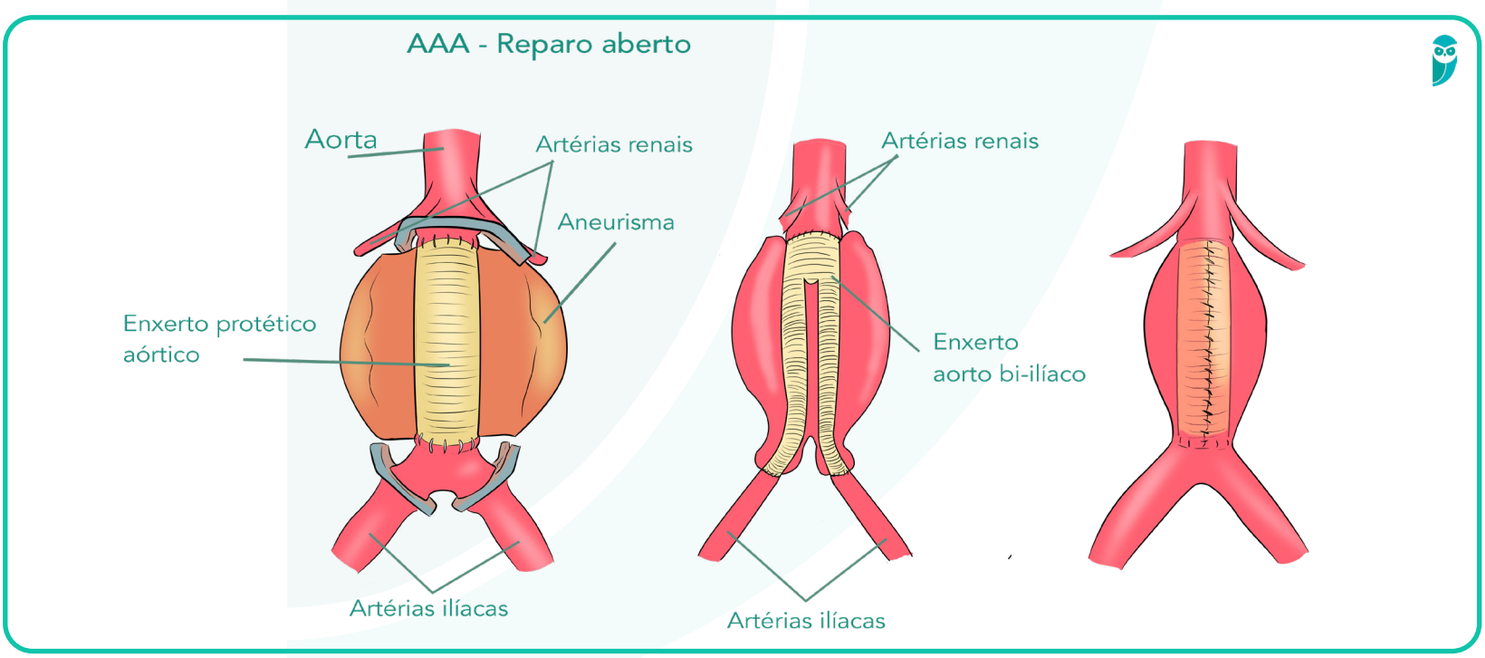
- **Cirurgia aberta:** envolve a substituição do segmento aórtico roto por um enxerto protético, que pode ser simples ou bifurcado. As opções de enxerto são de poliéster (por exemplo, Dacron) e politetrafluoroetileno (PTFE).



Tratamento cirúrgico do AAA. Fonte: Shutterstock

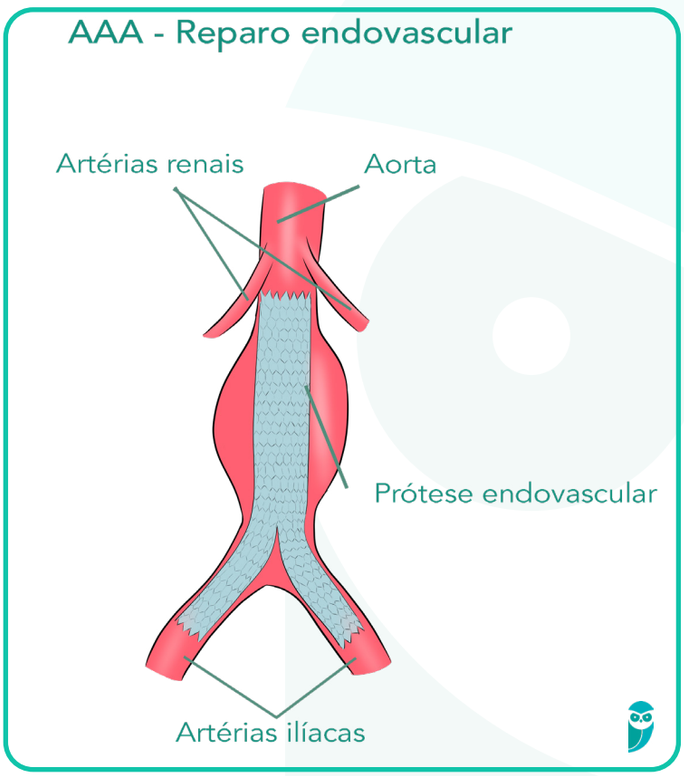


Tratamento cirúrgico do AAA. Enxerto protético bifurcado de Dacron. Fonte: Shutterstock.



Reparo aberto do AAA.

- **Reparo endovascular (REVA):** é a **via de escolha**, desde que haja disponibilidade e as condições anatômicas do aneurisma permitam. Envolve a colocação de endoprótese aórtica autoexpansível, que reveste a aorta e exclui o saco aneurismático da circulação, geralmente por meio de punção das artérias femorais. O reparo endovascular do AAA roto parece estar associado a uma menor morbidade e mortalidade perioperatória.

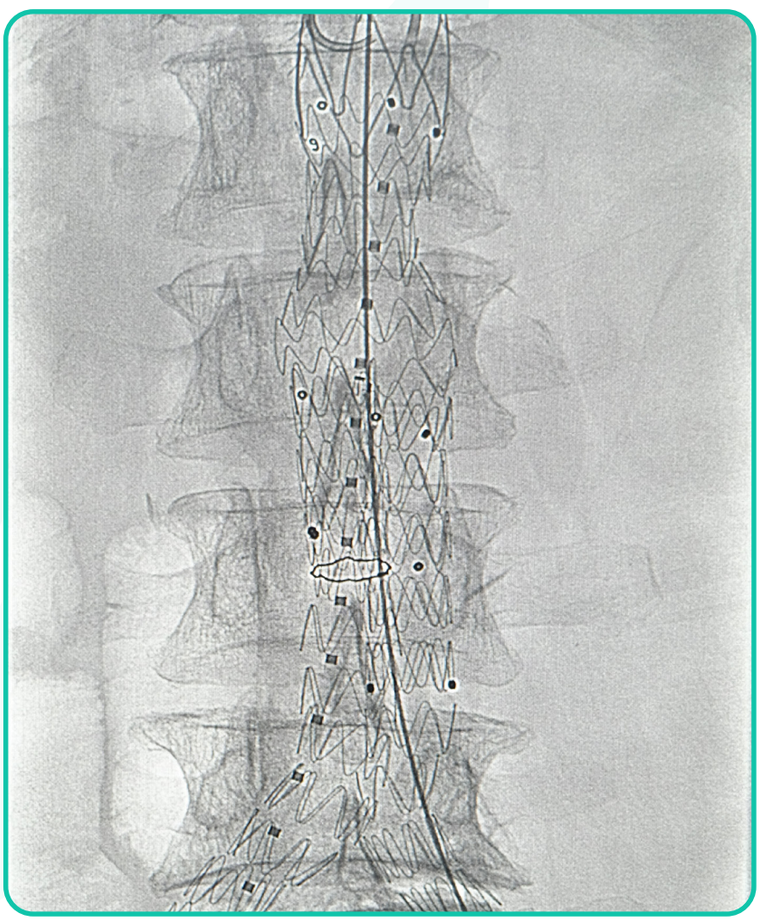


Dentre as vantagens da via endovascular em comparação à cirurgia convencional, podemos citar: o reparo pode ser realizado com anestesia local ou loco-regional, diminui a perda sanguínea, mantém a integridade da parede abdominal, reduz a morbidade e a mortalidade decorrentes das lesões iatrogênicas causadas pela exploração do hematoma retroperitoneal e anatomia distorcida.

Embora até 70% dos pacientes possam ser candidatos ao tratamento endovascular, o AAA rompido é mais frequentemente reparado com técnicas cirúrgicas abertas, devido à indisponibilidade de radiologia intervencionista na maioria dos serviços.



Tratamento endovascular de AAA infrarrenal. Fonte: Shutterstock.



Prótese endovascular bifurcada (aorto bi-ilíaco). Fonte: Shutterstock.

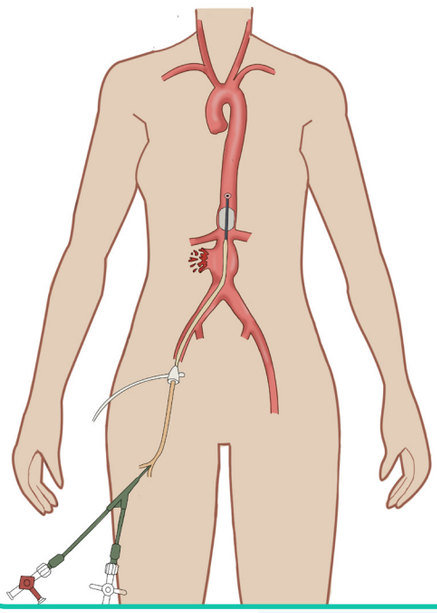
CURIOSIDADE



As principais contraindicações ao reparo endovascular dos aneurismas de aorta abdominal são:

- **Aneurismas localizados na altura ou acima das artérias renais.**
- **Colo aórtico < 0,7 cm.**
- **Presença de trombo ou calcificação circunferencial na região proximal de fixação da prótese.**

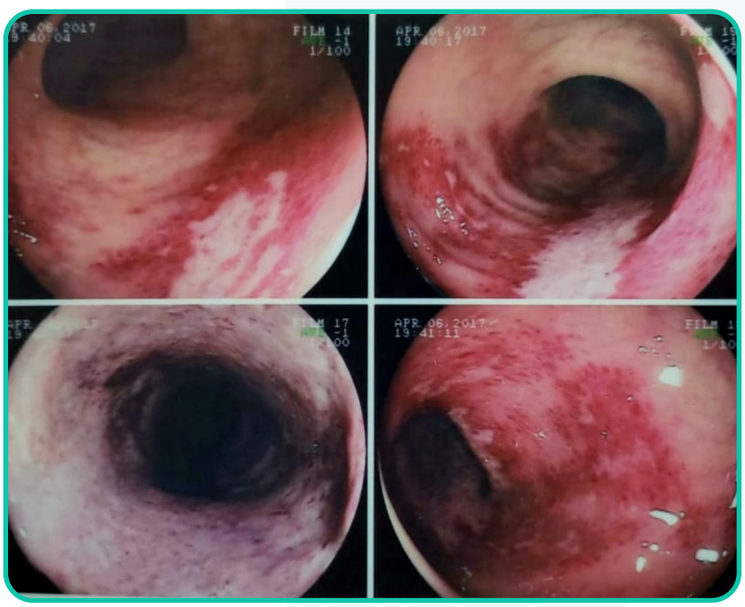
REBOA AAA



REBOA (*Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta*): consiste na passagem percutânea de um balão que deverá ser insuflado na **aorta proximal ao aneurisma roto** antes do reparo aberto ou endovascular, permitindo, dessa forma, controle do sangramento e melhora hemodinâmica. Indicada principalmente nos pacientes instáveis hemodinamicamente.

Apesar dos avanços nas técnicas cirúrgicas, anestesia cardiovascular e cuidados intensivos, a mortalidade cirúrgica após o reparo aberto do AAA rompido permanece alta, em torno de 30 a 50%.

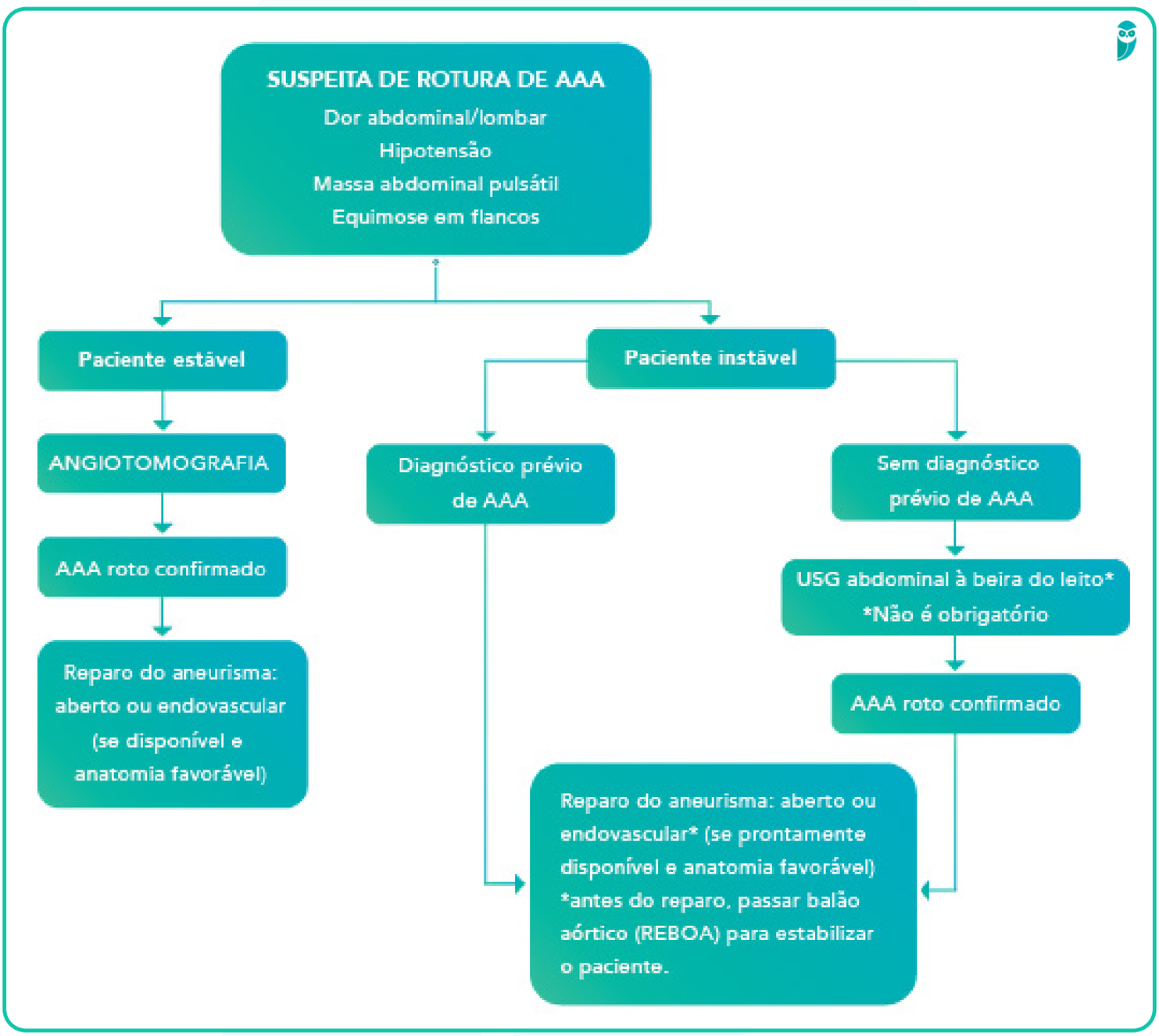




Vale a pena lembrar que **uma das complicações no reparo de AAA roto**, que as bancas adoram cobrar, é a **isquemia colônica**, por ligadura inadvertida da artéria mesentérica inferior, obstrução do seu óstio pela prótese aórtica ou mesmo pela hipotensão severa, comum nesses casos. As manifestações clínicas incluem dor abdominal, principalmente à esquerda, diarreia mucossanguinolenta e febre. O diagnóstico é feito por colonoscopia ou sigmoidoscopia, onde é visualizada mucosa edemaciada, friável, pálida, com nódulos hemorrágicos e transição abrupta (bem delimitada) entre mucosa lesada e normal.

Colite isquêmica. Fonte: acervo pessoal Dr. Élio Castro.

COLITE ISQUÊMICA: UMA DAS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES DO TRATAMENTO DO AAA ROTO



CAI NA PROVA

(ABC 2017) Os Aneurismas da Aorta Abdominal (AAA) são de importância especial por se tratar daqueles mais frequentes na prática clínica. Na maioria das vezes são assintomáticos e detectados em exames de rotina ou de forma ocasional. Qual o principal fator de risco de ruptura do AAA?

A) Extensão.
B) Diâmetro.
C) Localização.
D) Presença de Trombo.

COMENTÁRIO:

Correta alternativa B.

O principal fator de risco para rotura de um aneurisma é o diâmetro. Além disso, extensão, localização e presença de trombo não estão entre os principais fatores de risco para rotura.

CAI NA PROVA

(INSTITUTO E HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE ANÁPOLIS - IHOA 2017) Um homem de 70 anos procura a emergência com quadro de dor abdominal súbita e intensa periumbilical, acompanhada de síncope com sudorese profusa. Ao exame: regular estado geral, palidez (3+/4+), PA=70 x 30 mmHg e pulso filiforme taquicárdico, abdome doloroso difusamente com massa palpável mesoabdominal, pulsátil. À inspeção geral: aspecto sindrômico, estatura elevada, pectus escavatum, rosto afilado, micrognatia e pés chatos. Após a infusão de 1L de solução cristaloide, PA=100 x 60 mmHg. Que exame é mais bem indicado para o diagnóstico e planejamento terapêutico, nessa circunstância?

A) Angiografia.
B) Ultrassonografia abdominal.
C) TC com contraste
D) RNM com contraste.

COMENTÁRIO:

Temos um paciente idoso, com dor abdominal súbita associada a sinais de choque. Até aqui, nossa principal hipótese diagnóstica é um abdome agudo hemorrágico, resta saber a causa para decidirmos qual o melhor exame diagnóstico! Ele apresenta uma massa palpável e pulsátil em mesogástrio, típico de um aneurisma de aorta abdominal.

TRÍADE DO ANEURISMA ROTO DE AORTA ABDOMINAL
Massa pulsátil + dor abdominal ou lombar + hipotensão

E o autor ainda nos dá mais uma dica! Nosso paciente apresenta a síndrome de Marfan, caracterizada por crescimento excessivo de ossos longos, deslocamento do cristalino, descolamento da retina, rosto fino e estreito, pectus excavatum (tórax em funil) e/ou carinatum (peito de pombo), escoliose, pés chatos, micrognatia, disfunção da válvula cardíaca e dilatação aórtica com propensão à ruptura da aorta.
Bom, já temos nosso diagnóstico: aneurisma de aorta abdominal roto! Agora, vamos às alternativas:
Incorreta a alternativa A. A angiografia é um exame bem mais invasivo que a angiotomografia, além da nefrotoxicidade, devido a altas doses de contraste que, em um paciente com provável ruptura de aneurisma de aorta abdominal e com depleção de volume, não está indicada. Além disso, na presença de trombos intraluminais, o exame é incapaz de avaliar precisamente o tamanho da dilatação.
Incorreta a alternativa B. A ultrassonografia estaria indicada se o paciente mantivesse instabilidade hemodinâmica, pois não é invasiva e pode ser feita à beira do leito. Se o aneurisma estiver rompido, hematoma retroperitoneal pode ser visto, mas o local da ruptura geralmente não é identificado, o que prejudica o planejamento terapêutico.

Correta a alternativa C: Nosso paciente chegou com instabilidade hemodinâmica e, após a infusão de 1 litro de cristaloide, houve melhora da hipotensão. Dessa forma, podemos realizar a tomografia computadorizada com contraste endovenoso, também chamada de angiotomografia, considerado o melhor exame para o diagnóstico do aneurisma abdominal. Além de definir a extensão do aneurisma, fornece informações anatômicas importantes para planejar o reparo urgente e verificar a viabilidade de fazer um reparo endovascular. A abordagem endovascular apresenta menor risco de morbimortalidade perioperatória, sobretudo em pacientes com múltiplos fatores de risco.
Incorreta a alternativa D. A ressonância não apresenta vantagens em relação à tomografia contrastada. Além disso, é um exame de alto custo, pouco disponível e mais demorado para sua realização.

CAI NA PROVA

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI 2018) Paciente 67 anos, hipertenso, tabagista, diabético com controle glicémico adequado, é admitido no serviço de urgência com queixa de dor abdominal difusa, iniciada há 3 horas. A admissão, consciente, orientado, conversando, eupneico, pulsos cheios e todos presentes, Fc 112bpm, Pressão Arterial: 90/50mmHg, abdome dolorido difusamente e com massa pulsátil em mesogástrio. Realizado Angio TC de abdome e pelve com contraste venoso e evidenciado dilatação da aorta abdominal de 6,1cm que se extende para artéria ilíaca comum esquerda (2,2cm) associada a extensa área de borramento do retroperitônio sugestivo de hematoma com deslocamento cranial do rim esquerdo, sem outras alterações. Considerando o caso apresentado, assinale a opção CORRETA.

A) Trata-se provavelmente de rotura de aneurisma de artéria renal esquerda, sendo necessária abordagem cirurgia de caráter de urgência.
B) Aneurisma de aorta abdominal em expansão, mas sem sinais de rotura, iniciar vigilância intensiva com transferência para UTI, controle da dor e monitorização.
C) Aneurisma roto de aorta abdominal com indicação cirúrgica em caráter de emergência.

D) Aneurisma roto de aorta abdominal, iniciar compensação clínica em ambiente de terapia intensiva com reposição volêmica e hemotransfusão com objetivo de deixá-lo normotenso e correção cirúrgica após melhora clínica nas primeiras 24 horas.

E) Dissecção aguda de aorta abdominal sintomática com indicação de tratamento de urgência por via endovascular.

COMENTÁRIO:

Temos um paciente idoso, com dor abdominal difusa associada a sinais de choque (hipotensão e taquicardia). Ele ainda apresenta uma massa palpável em mesogástrio, típico de um aneurisma de aorta abdominal.

E o autor ainda nos dá mais informações! A angiotomografia apresenta dilatação importante da aorta (6,1 cm) com hematoma retroperitoneal, fechando nosso diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal roto.

Incorreta a alternativa A. A dilatação é de aorta, e não da artéria renal esquerda. O hematoma provocado pela ruptura do aneurisma apenas desloca cranialmente o rim esquerdo, o que fala a favor de um aneurisma de aorta infrarrenal.

Incorreta a alternativa B. A presença de extensa área de borramento do retroperitônio é sugestiva de hematoma e quer dizer que houve ruptura do aneurisma. Além disso, o paciente apresenta quadro clínico compatível (dor abdominal, hipotensão e taquicardia).

Correta a alternativa C: Aneurisma roto de aorta requer tratamento cirúrgico de emergência.

Incorreta a alternativa D. Devemos iniciar uma compensação clínica com reposição volêmica e provável transfusão sanguínea. Mas, a cirurgia não deve ser postergada, nem se deve aguardar a melhora clínica em 24 horas.

Incorreta a alternativa E: dissecção espontânea de aorta infrarrenal é rara (mais comum na aorta ascendente e descendente). Além disso, o paciente com dissecção de aorta, se for sintomático, apresenta dor abdominal e sinais de isquemia de membros inferiores. E a presença de sinais de choque com hematoma retroperitoneal é característica de ruptura de aorta, o que fala contra uma dissecção.

CAI NA PROVA

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 2021) Homem, 71 anos de idade, é admitido com dor abdominal em mesogástrio, contínua, com irradiação lombar há 7 horas. Nega trauma ou queda. Trouxe uma angiotomografia prévia que confirmou aneurisma de aorta abdominal infra-renal. Exame físico: corado, consciente, eupneico, PA = 160/90 mmHg, FC = 92 bpm, com dor à palpação da aorta abdominal. Pulsos presentes e normais em membros inferiores. Qual é a conduta mais adequada?

A) Tratamento endovascular de urgência do aneurisma de aorta abdominal, se as condições anatômicas do aneurisma forem favoráveis.

B) Manter rigoroso controle pressórico em níveis de 120/80 mmHg, avaliação e melhor preparo do paciente para cirurgia convencional.

C) Tratamento cirúrgico convencional de urgência por quadro de aneurisma de aorta abdominal roto e tamponado.

D) Solicitar nova angiotomografia de urgência para afastar aneurisma inflamatório e decidir pela necessidade ou não de tratamento cirúrgico.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: Estamos diante de um paciente com diagnóstico prévio de aneurisma de aorta, estável e com queixa de dor lombar (provável rotura do AAA). Como ele já tem diagnóstico prévio, a conduta é o reparo cirúrgico de urgência, que pode ser feito por via endovascular se as condições anatômicas permitirem.

Incorreta a alternativa B. O paciente apresenta um AAA sintomático, possivelmente com rotura. Por isso, tem indicação de cirurgia de urgência, que pode ser feita pela via endovascular, que apresenta menor morbidade e mortalidade precoce.

Incorreta a alternativa C. É provável que o paciente tenha mesmo uma ruptura de aneurisma de aorta e que esteja tamponado, pois não apresenta sinais de instabilidade. Mas, seria necessária uma angiotomografia para confirmar a ruptura. Além disso, a via de acesso preferencial seria a endovascular, desde que haja disponibilidade e as condições anatômicas permitam.

Incorreta a alternativa D. Aneurisma de aorta sintomático tem indicação cirúrgica de urgência. Como o paciente apresenta diagnóstico prévio, não há necessidade de realizar nova tomografia.

CAI NA PROVA

(REVALIDA NACIONAL - INEP - REVALIDA - INEP 2013) Mulher com 64 anos de idade, com antecedentes de hipertensão arterial há cerca de 20 anos e tabagista (30 maços-ano), em uso de enalapril - 20 mg de 12/12h, foi trazida à Emergência de um hospital terciário com quadro de dor lombar de forte intensidade e início súbito, sem irradiação, que foi acompanhada por síncope, sem pródromos, iniciada há duas horas. Na admissão hospitalar estava consciente, orientada, anictérica, com palidez cutaneomucosa. Temperatura axilar = 36°C, pressão arterial = 70 x 45 mmHg, frequência cardíaca = 118 bpm, frequência respiratória = 18 irpm. Os exames do aparelho cardiovascular e pulmonar não demonstraram alterações. O abdome apresentava equimoses em ambos os flancos, e era levemente doloroso à palpação em mesogástrio e hipogástrio, com massa pulsátil em região do mesogástrio. Ruídos hidroaéreos presentes. Nos membros inferiores havia redução da temperatura distalmente e bilateralmente e redução da amplitude de todos os pulsos. Os exames laboratoriais iniciais revelaram: Leucócitos = 12.000/mm³ (segmentados = 74%, Hemoglobina = 12,1 g/dl; Hematócrito = 36,3%; Plaquetas = 231.000/mm³; Glicemia = 84 mg/dl (VR = 80- /dl); Ureia = 45 mg/dl (VR = 20-35 mg/dl); Creatinina = 1,2 mg/dl (VR = 0,8-1,4 mg/dl); Amilase = 352 U/L (VR = 4-400 U/L); TGO = 26 U/L (VR < 35 U/L) e TGP = 31 U/L (VR < 35 U/L). Considerando a condição clínica atual da paciente, o exame a ser realizado para confirmação diagnóstica é:

A) Ultrassonografia abdominal.
B) Lavado peritoneal com solução salina.
C) Angiorressonância magnética do abdome.
D) Tomografia computadorizada do abdome.
E) Angiografia aórtica e de membros inferiores.

COMENTÁRIO:

Vamos resumir o que há de importante nesse enunciado enorme! Temos uma paciente feminina, hipertensa e tabagista (fatores de risco para rotura de AAA), apresentando dor lombar súbita e de forte intensidade, associada a sinais de choque (palidez cutaneomucosa, hipotensão e taquicardia) e massa abdominal pulsátil. Estamos diante da tríade do aneurisma de aorta roto: dor abdominal/lombar, massa pulsátil e hipotensão arterial.

A presença de equimose em flancos é chamada de sinal de Grey Turner, sugestivo de sangramento retroperitoneal.

Bom, já temos nosso diagnóstico clínico: aneurisma de aorta abdominal roto! Agora, vamos às alternativas:

Correta a alternativa A: Quando houver suspeita de ruptura de aneurisma de aorta abdominal, no paciente instável, sem um diagnóstico prévio, a ultrassonografia pode confirmar a existência de um aneurisma, se disponível imediatamente (mas não é obrigatório). Tem a vantagem de poder ser realizada à beira do leito ou na sala de cirurgia enquanto o paciente está sendo reanimado, sem causar um atraso indevido no atendimento. Pode ser visualizado um hematoma retroperitoneal, mas o local da ruptura geralmente não é identificado.

Incorreta a alternativa B. Não há indicação de lavado peritoneal diagnóstico (LPD) na suspeita de um aneurisma de aorta roto. O LPD é indicado em vítimas de trauma instáveis, para identificar um possível foco hemorrágico intra-abdominal.

Incorreta a alternativa C. A angiorressonância magnética do abdome pode diagnosticar um aneurisma de aorta, mas é um exame pouco disponível, de alto custo, demorado e que requer estabilidade hemodinâmica.

Incorreta a alternativa D. O melhor exame para o diagnóstico de um aneurisma de aorta roto é a angiotomografia, que, além de definir a extensão do aneurisma, fornece informações anatômicas importantes para planejar o reparo urgente e para verificar a viabilidade de ser feito um reparo endovascular. No entanto, para sua realização, é necessária estabilidade hemodinâmica.

Incorreta a alternativa E. A angiografia é um exame bem mais invasivo que a angiotomografia. Além da nefrotoxicidade, devido a altas doses de contraste, na presença de trombos intraluminais, o exame é incapaz de avaliar precisamente o tamanho da dilatação.

CAI NA PROVA

(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RORAIMA - SUS - RR 2014) Sra. Clotilde, 80 anos, é submetida à cirurgia de emergência para tratamento de ruptura de aneurisma de aorta abdominal. No terceiro dia de pós-operatório queixa-se de dor de forte intensidade em flanco esquerdo e apresenta diarreia mucossanguinolenta. O diagnóstico mais provável é:

A) Infarto êntero-mesentérico.
B) Diverticulite.
C) Colite isquêmica do cólon esquerdo.
D) Enterocolite pseudomembranosa.
E) Enterocolite infecciosa.

COMENTÁRIO:

Meu querido aluno, todas as alternativas apresentam patologias que podem se apresentar com dor abdominal e diarreia com sangue. O detalhe está no fator de risco, ou seja, na cirurgia para tratamento de ruptura de aneurisma de aorta. E por que isso? Bom, você deve

imaginar como é uma cirurgia de urgência por ruptura de aneurisma de aorta! Paciente grave, instável, com hemoperitônio volumoso... As chances de uma lesão iatrogênica são grandes e pode ter ocorrido uma ligadura inadvertida da artéria mesentérica inferior. Outras possibilidades são a oclusão do óstio da artéria mesentérica inferior pela prótese aórtica ou mesmo resultado de hipotensão severa. Lembrando que a junção retossigmoideana (ponto de Sudeck) é um segmento colônico mais propenso a sofrer isquemia, por apresentar menor circulação colateral. Dessa forma, nossa principal hipótese diagnóstica é uma colite isquêmica do cólon esquerdo.

Incorreta a alternativa A. As características típicas de uma isquemia mesentérica aguda, devido à obstrução da artéria mesentérica superior, são uma dor abdominal súbita, difusa ou mesogástrica, de forte intensidade, sem melhora com o uso de opioides, e com exame físico desproporcional à intensidade da dor abdominal, em um paciente idoso com fatores de risco para aterosclerose e/ou embolia arterial (ex.: infarto recente, fibrilação atrial, doença valvar). Não é comum apresentar diarreia mucossanguinolenta, mas pode ocorrer em fases avançadas da isquemia.

Incorreta a alternativa B. O quadro clínico típico da diverticulite aguda é dor em fossa ilíaca esquerda associada à febre e sinais de peritonite localizada. Pode apresentar sangramento nas fezes, mas não é comum. Além disso, não tem relação com a cirurgia relatada.

Correta a alternativa C: O quadro clínico e histórico da cirurgia aórtica recente faz com que nossa principal hipótese diagnóstica seja uma colite isquêmica do cólon esquerdo, por provável ligadura da artéria mesentérica inferior.

Incorreta a alternativa D. A colite pseudomembranosa, causada pelo Clostridioides difficile, geralmente está associada ao uso de antibióticos (principalmente fluoroquinolonas, clindamicina, penicilinas e cefalosporinas de amplo espectro). A manifestação clínica típica é a diarreia aquosa (≥3 fezes moles em 24 horas), geralmente associada à dor abdominal inferior em cólicas, febre baixa, náuseas e anorexia. Nas formas graves, pode levar ao megacólon tóxico. A presença de pseudomembranas à sigmoidoscopia flexível é altamente sugestiva da colite causada por C. difficile e está presente em 25 % dos pacientes com doença leve e 87% na colite fulminante.

Incorreta a alternativa E. A enterocolite infecciosa pode apresentar dor abdominal, geralmente difusa, e diarreia mucossanguinolenta, mas, com o histórico da nossa paciente, não é a causa mais comum.

CAPÍTULO
5.0 RUPTURA ESPLÊNICA ESPONTÂNEA

A ruptura esplênica na ausência de trauma é rara, mas pode ser fatal. Não costuma ser cobrada em provas, mas considero importante você saber quais são as causas que podem levar à ruptura esplênica espontânea.



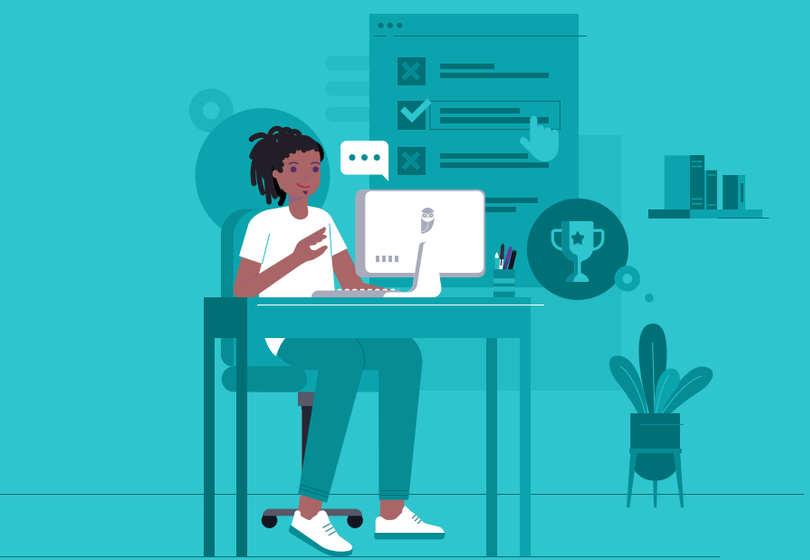
FATORES DE RISCO PARA RUPTURA ESPLÊNICA ESPONTÂNEA

- Neoplasia (por exemplo, leucemia, linfoma) – 30%.
- Infecção (por exemplo, mononucleose infecciosa, citomegalovírus [CMV], HIV, endocardite, malária) – 27%.
- Doença inflamatória/distúrbios não infecciosos (por exemplo, pancreatite aguda e crônica) – 20%.
- Relacionados a medicamentos e tratamentos (por exemplo, anticoagulação, fator estimulador de colônias de granulócitos – G-CSF, terapia trombolítica, diálise) – 9 %.
- Causas mecânicas (por exemplo, relacionadas à gravidez, esplenomegalia congestiva) – 7%.
- Idiopática – 7 %.

Não se esqueça de que **o sinal de Kehr**, dor referida no ombro esquerdo, pode indicar rotura esplênica espontânea. O tratamento geralmente requer cirurgia de emergência com esplenectomia. No entanto, em casos selecionados, pode ser tomada conduta conservadora nos pacientes estáveis hemodinamicamente, assim como nas lesões esplênicas traumáticas.

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/tnXy

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20ª edição.
2. *UpToDate:*
3. Gravidez ectópica: manifestações clínicas e diagnóstico.
4. Gravidez ectópica: tratamento cirúrgico.
5. Avaliação e tratamento de cisto ovariano rompido.
6. Características clínicas e diagnóstico de aneurisma da aorta abdominal.
7. Tratamento de aneurisma de aorta abdominal sintomático (não rompido) e rompido.
8. Correção cirúrgica e endovascular de aneurisma de aorta abdominal roto.

CAPÍTULO

8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

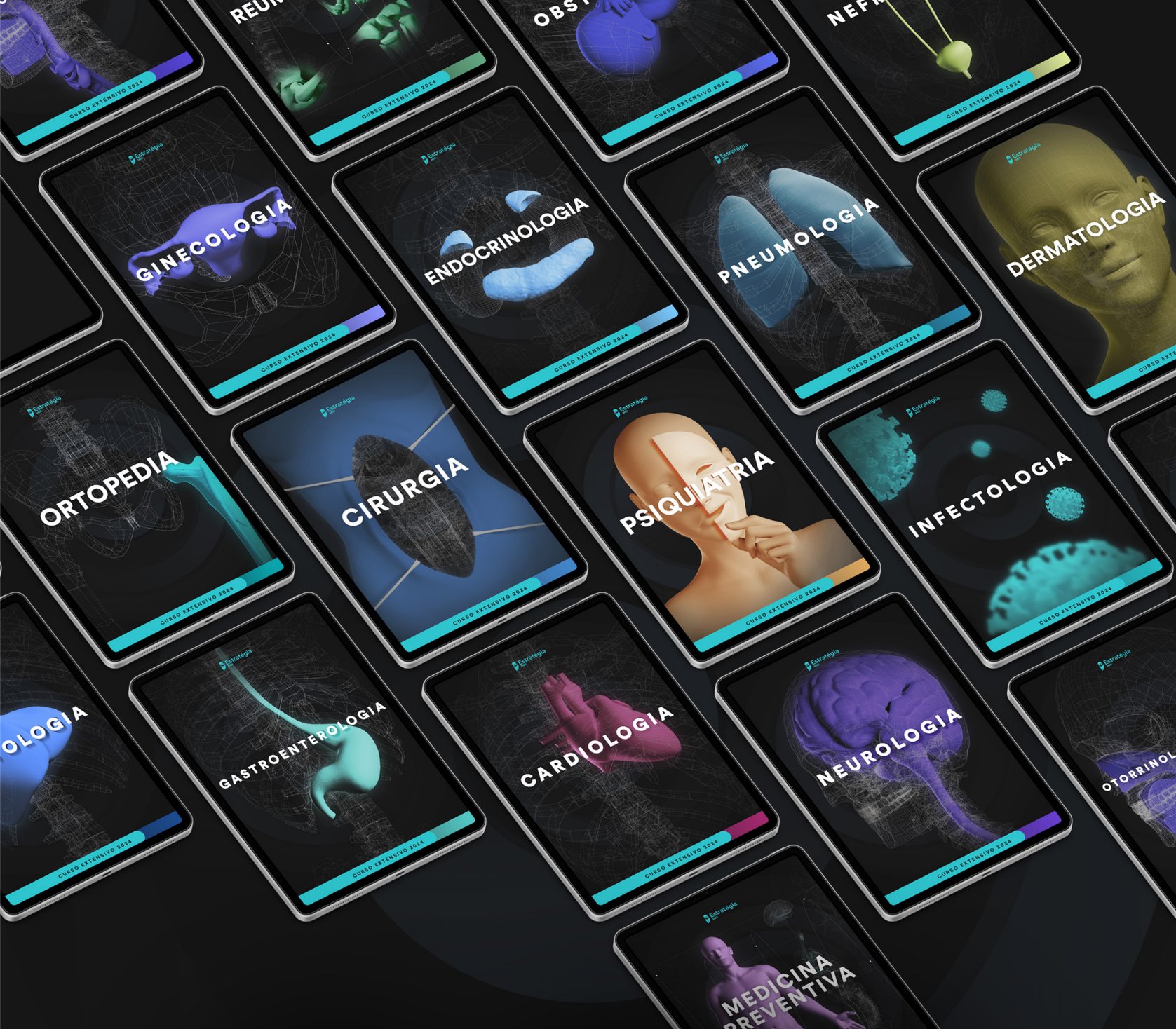
Meu querido aluno, finalmente terminamos o tema Urgências Abdominais! É um assunto muito importante na cirurgia geral e que eu adoro, por ser muito cobrado em provas e, principalmente, por fazer parte do meu dia a dia no pronto-socorro. Se você leu todos os livros de abdome agudo, assistiu nossas vídeo-aulas e resolveu as principais questões, tenho certeza de que está pronto para ir bem na sua prova!

Lembre-se de que estou a sua disposição para tirar dúvidas no Fórum de Dúvidas do Estratégia MED, terei o maior prazer em ajudá-lo.

Bons estudos e fique com Deus!

Abraços,

Renatha Paiva.



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED